内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·胃炎

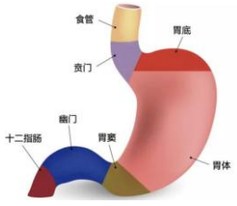
（性感认识：幽门螺杆菌当然在幽门附近）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、急性糜烂出血性胃炎

可能可能最可能：**NSAIDs**、**应激**、饮酒后急性上腹痛、上消化道出血，急诊**胃镜**诊断+止血

（1）非甾体类抗炎药 NSAIDs（如阿司匹林/乙酰水杨酸、吲哚美辛/消炎痛、保泰松、布洛芬）：抑制 **COX-1→前列腺素↓**（前列腺素是胃黏膜的保护性因素）



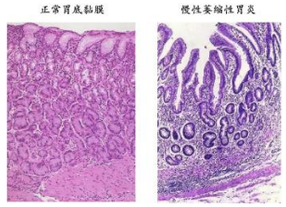
（2）应激机制

①胃酸↑（糖皮质激素）、组胺及 5-HT↑

②前列腺素↓→黏液分泌↓、屏障破坏、黏膜细胞增殖不足

③胃黏膜缺血缺氧坏死（儿茶酚胺）应激应急不分家

（3）精神因素可为急性出血性胃炎（不是慢性胃炎）、肠易激综合征的病因



非特异性炎：淋巴细胞和浆细胞浸润为主（临江）

二、慢性胃炎

1.病因：**Hp 感染（最常见）**、十二指肠-胃反流、NSAIDs、饮酒、自身免疫等

2.**萎缩**性胃炎

（1）**胃镜**：黏膜变薄、皱襞稀疏平坦、黏膜下血管透见、腺体变小和减少，淋巴细胞和浆细胞浸润（若出现中性粒细胞提示活动期），**腺上皮化生**（肠上皮化生、假幽门腺化生）

（2）处理癌前情况 肠上皮化生易癌变（尤其是结肠型的不完全肠化）

①在根除 Hp 的前提下，补充维生素、硒

②药物不能逆转的局灶重度异型增生和原位癌→**胃镜黏膜下剥离术+定期随访**

上皮内瘤变ⅢⅢ级

（3）A 型 VS B 型胃炎

HP呈灶状分布

	A 型/自身免疫性胃炎	B 型/多灶萎缩性胃炎
发病率	低	**高**
病因	自身**免疫**	**Hp（常伴消化性溃疡）**
抗壁细胞和内因子抗体	+	-
好发部位	**胃底、胃体** 壁细胞存在于胃体、胃底	**胃窦**（有逗比）Hp多在胃窦
胃酸分泌	**明显↓（缺乏）**胃癌	正常或↓
血胃泌素	**↑** 负反馈	**↓**
贫血	**巨幼贫（$VitB_{12}$↓，MCV＞100）**更常见 缺铁贫（HCl↓，MCV＜80）	无恶性贫血
治疗	**糖皮质激素、注射 $VitB_{12}$**	**根除 Hp**

盐酸使铁处于溶解状态→促进铁吸收。盐酸↓→铁吸收↓

口服是为了让VitB12在回肠吸收，而此时缺乏内因子，不能帮助其在回肠吸收

G细胞主要存在于胃窦、幽门部，G细胞分泌胃泌素：Hp破坏G细胞→胃泌素↓

1 理顺应激机制：

①.机体在应激应急的情况下，释放更多的糖皮质激素，直接促进胃酸分泌增多，出现急性胃炎

②.增多的糖皮质激素，具有抗炎作用，可使前列腺素减少（前列腺素是一种炎症介质），而前列腺素还具有促进黏液和碳酸氢盐分泌，扩张黏膜内的微血管，增加其血供，促进黏膜上皮细胞修复和保持其完整性的作用。故应急时其前列腺素含量降低，可出现急性胃炎

③.应激应急时，可释放出儿茶酚胺，如肾上腺素，可收缩血管，导致胃黏膜缺血坏死，出现急性胃炎。

2 理顺处理措施：

①.抗氧化剂、VitC、VitE、叶酸、胡萝卜素、硒等可逆转不典型增生，塞来昔布也有逆转肠上皮化生的作用。

②.而药物不能逆转的局灶（不能是弥漫病变）重度异型增生和原位癌，可内镜下胃黏膜剥离术ESD+定期随访。

串联外科学：对于＜2cm、无溃疡的分化型黏膜内癌，才用内镜下胃黏膜剥离术ESD（首选）或切除术+定期胃镜随访。

3 理顺表格内容：

①.自身免疫性/A型胃炎多见于北欧人群，国内发病率较低，其机制为抗壁细胞和抗内因子抗体攻击自身组织结构，属于自身免疫性疾病。

因壁细胞多见于胃底胃体，故A型胃炎好发于胃底胃体，且其自身抗体攻击壁细胞，而壁细胞是产生胃酸的主要细胞，故A型胃炎的患者胃酸含量明显减少或缺乏。

又因胃酸减少，负反馈的是促胃液素/胃泌素含量增加。

因胃酸减少，而酸有助于保持铁的溶解状态（即以离子形式存在），促进其吸收，因此A型胃炎可出现缺铁性贫血（但比较少见，因体内铁的主要来源是衰老的红细胞）。

主要是因A型胃炎的抗壁细胞、内因子的自身抗体，导致其胃酸、内因子缺乏，VitB12吸收障碍，出现“核幼浆老”的巨幼贫，此时称为“恶性贫血”。

因糖皮质激素具有抗免疫的作用，因此可用糖皮质激素治疗自身免疫性胃炎，且强调注射VitB12以避免恶性贫血的出现，因口服时还是因胃酸、内因子的缺乏无法吸收，没有治疗效果。

②.B型胃炎主要与幽门螺旋杆菌Hp感染（发病率较高）相关，而Hp感染多呈现灶状分布，故又称为多灶萎缩性胃炎。

因Hp可产生尿素酶，可分解尿素产生NH_3，以中和胃酸形成利于其定居的微环境，胃底胃体因壁细胞的大量存在，胃酸含量较高，因此Hp更易感染胃窦部，即幽门螺旋杆菌，因此B型胃炎好发于胃窦部。

而感染胃窦部，可损害G细胞，导致B型胃炎患者的血胃泌素/促胃液素含量降低，可导致B型胃炎患者的胃酸含量降低，但因患者的壁细胞并未损害，故B型胃炎患者的胃酸含量称为正常或降低，但绝对称不上缺乏。

故B型胃炎患者的治疗措施在于根除Hp感染。

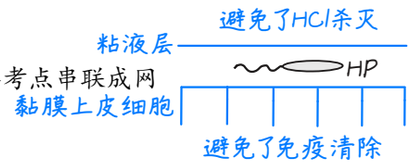
可能可能最可能：
①A 型胃炎：胃底胃体萎缩、壁细胞和内因子抗体、胃酸缺乏、胃泌素增加、常合并巨幼贫（MCV＞100）
②B 型胃炎：胃窦萎缩、胃泌素减少、Hp(+)

胃酸小结：
①胃酸明显减少/缺乏（MAO=0）：A 型胃炎、胃癌　最大胃酸分泌　肿瘤细胞破坏壁细胞,肿瘤细胞具有异型性,分化差,不能产生胃酸→胃酸明显减少/缺乏
②胃酸减少：B 型胃炎伴大量 G 细胞丧失
③胃酸正常或减少：B 型胃炎、胃溃疡I/IV型　屏障功能↓
④胃酸增加：十二指肠溃疡、胃溃疡II/III型　(123)十二指肠溃疡患者壁细胞数量↑(侵袭因素↑)→胃酸增多
⑤胃酸明显 ttsx 增加：胃泌素瘤

平时说的溃疡是胃溃疡I型
胃溃疡I工、I工工、IV型是特殊的消化性溃疡

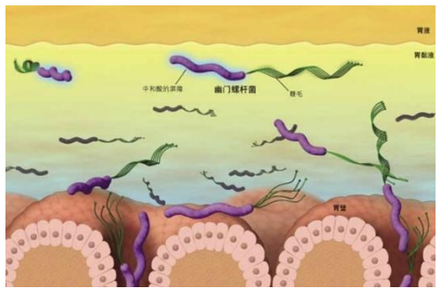
专题串联 • Hp

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



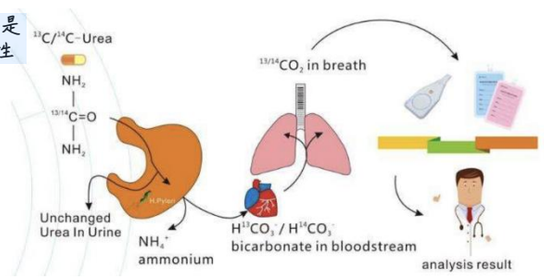
1.幽门螺杆菌的致病机制
①Hp 依靠鞭毛穿过胃粘液层，定居在粘液层与消化道黏膜上皮细胞之间，避免胃酸杀灭和被机体免疫功能清除
②Hp 释放尿素酶分解尿素产生 NH_3，NH_3 中和胃酸后形成利于它定居的局部微环境，使感染慢性化
③Hp 通过产生 NH_3、空泡毒素、细胞毒素类相关蛋白，加之菌体细胞壁作为抗原诱导免疫反应，加重炎症反应

2.与 Hp 有关的疾病：**慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌、胃淋巴瘤**
注意：大部分急性胃炎、胃食管反流病、A 型慢性萎缩性胃炎与 Hp 无关



3.检查　④
①**非侵入性的尿素呼气试验：首选、金标准、复查**
②快速尿素酶试验：侵入性检查首选　需要胃镜
③Hp 抗**原**：简单准确　检测大便
④Hp 抗**体**：复查不出现假阴性（**不能**判断根除）抗体存在时间很长,可能HP已根除但抗体仍存在实际有感染,但检测结果为阴性

4.治疗　做HP根除治疗时做检查,此时PPI可能把HP抑制了,检查结果可能是阴性(假阴性),但Hp抗体的检查不会出现阴性,所以也不会有假阴性
①**四**联疗法：**PPI+铋剂+2 种抗生素**
（四克拉的镯子让花甲之年的阿莫娶到了芊夫人：
四环素、克拉霉素、喹诺酮类、甲硝唑/替硝唑、
阿莫西林、氨苄西林、呋喃唑酮）如左氧氟沙星



②疗程 **10-14** 天；根除 Hp 至少 **4** 周后复查　减少假阴性的出现
若做根除Hp治疗的一开始就做检查,PPI会抑制Hp,可能会出现阴性结果,但Hp并没有被完全清除,即假阴性

真题解析 • 胃炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2015N171 X 根除胃幽门螺杆菌治疗时，常用的药物有
A.雷尼替丁
B.奥美拉唑

4.治疗
①四联疗法：PPI+铋剂+2 种抗生素
（四克拉的镯子让花甲之年的阿莫娶到了芊夫人：
四环素、克拉霉素、喹诺酮类、甲硝唑/替硝唑、
阿莫西林、氨苄西林、呋喃唑酮）如左氧氟沙星

④理顺知识点：
非侵入性尿素呼气试验UBT是临床上检测幽门螺旋杆菌Hp感染的首选方法,也是金标准。
指受试者口服含有碳同位素标记(13C或14C)的尿素胶囊或溶液,若胃内存在幽门螺旋杆菌,其产生的尿素酶可将尿素迅速分解为NH3和带有同位素碳标记的CO2,随后可经胃黏膜可吸收入血,随血液循环到达肺部,最终呼出。即UBT检测的是CO2,不是NH3,且值得注意的是复查Hp感染时也是首选非侵入性尿素呼气试验UBT。

答案:1 BD

C.硫糖铝
D.克拉霉素

2.2017N50 A 阿司匹林引起 NSAID 溃疡的最主要的机制是
A.抑制 COX-1 前列腺素↓
B.抑制 COX-2
C.同时抑制 COX-1 和 COX-2
D.局部作用

3. 2018N50 A 多灶萎缩性胃窦炎最主要的病因是
A.口服非甾体抗炎药　B型
B.胆汁反流
C.幽门螺杆菌感染
D.自身免疫性抗体

4.2019N156 X 有助于诊断自身免疫性胃炎的实验室检查有
A.血清维生素 B_{12} 水平 内因子缺乏　A型
B.幽门螺旋杆菌检测 B型胃炎
C.血清内因子抗体
D.血清抗壁细胞抗体

5. 2020N156 X 自身免疫性慢性胃炎患者产生巨幼细胞贫血的机制是
A.胃壁细胞分泌内因子减少　A型
B.内因子抗体致其功能异常
C.胃吸收维生素 B_{12} 减少　在回肠吸收:VitB12(需要内因子)、胆盐
D.回肠吸收维生素 B_{12} 减少

6. 2022N51 A 慢性胃窦胃炎最常见的病因是
A.幽门螺杆菌感染　B型
B.十二指肠-胃反流
C.自身免疫
D.胃黏膜营养因子缺乏

思维导图·胃炎（含胃酸小结 & Hp 小结）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

